

保健・医療・介護・福祉
(と多職種連携)

講義の目的



保健・医療・介護・福祉制度の基礎と相互関係を理解する



多職種連携の重要性を学ぶ



社会医学的視点を持った臨床医の在り方を考える

健康の社会的決定要因 (SDH: Social Determinants of Health)

健康は医療だけでなく、
社会的・経済的・文化的要因に影響される

教育、収入、職業、住環境、社会的孤立が健康に影響

地域連携や多職種連携が必要な理由の根拠

健康の社会的決定要因「確かな事実」

社会格差

ストレス

幼少期

社会的排除

労働

失業

社会的支援

薬物依存

食品

交通

医師が診察室で見ている病気の背景には、生活・労働・家庭・地域がある。

参考：

<https://www.tmd.ac.jp/med/hlth/whocc/pdf/solidfacts2nd.pdf>

同じ病気でも、同じ経過にはならない

背景	健康への影響
低所得	受診控え、食事の偏り
独居	服薬管理困難、孤立
不安定雇用	通院継続困難
交通手段なし	医療・介護サービスにアクセス困難

医療だけでは説明できない健康格差

幼少期の環境は将来の健康につながる

妊娠期・乳幼児期の栄養
養育環境
虐待・ネグレクト
教育・家庭環境

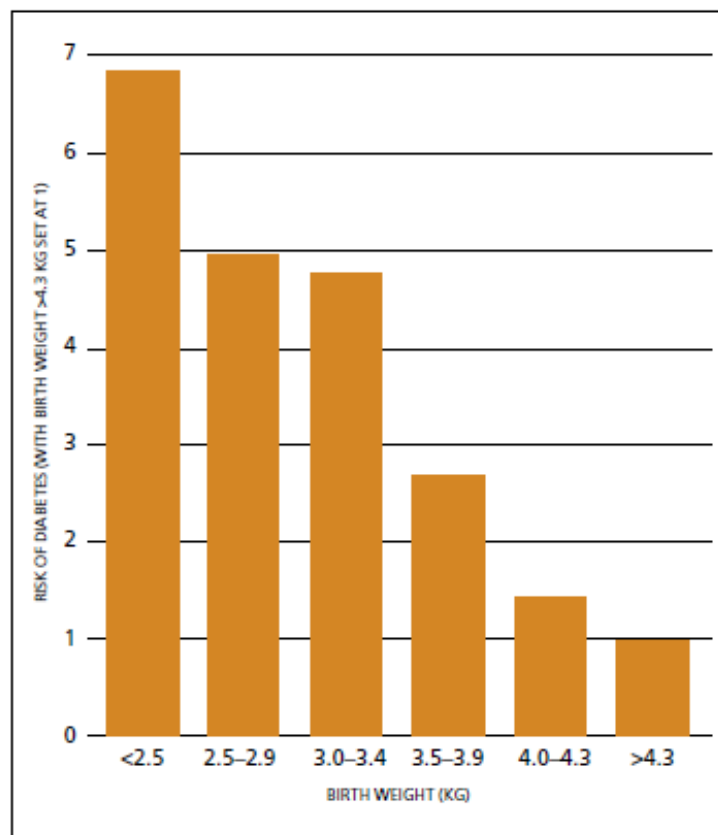


成人後の
生活習慣病・メンタルヘルス

人生の早い時期の環境が、その後の健康に影響する

Fig. 2. Risk of diabetes in men aged 64 years by birth weight

Adjusted for body mass index



<https://www.tmd.ac.jp/med/hlth/whocc/pdf/solidfacts2nd.pdf>

労働と失業（働き方・雇用と健康）

「働き方」も「働けないこと」も健康に影響する。

労働

- 長時間労働
- 裁量権が低い
- ハラスメント



• ストレス



• 心血管疾患・うつ病

失業

- 失業
- 収入減少
- 社会的孤立



• 受診控え・うつ病・
健康悪化

4領域の役割

領域	主目的	対象	医師との関係
保健	予防・健康増進	地域住民	健診・感染症・ 母子保健
医療	診断・治療	患者	主担当
介護	生活支援	要介護者	主治医意見書・ 在宅医療
福祉	生活困難の支援	障害・貧困・ 児童など	制度につなぐ

保健の特徴

保健

地域・集団を見る
患者一人ひとりを診る

医療

健康課題を把握
病気を診断・治療する

連携

保健の役割

- 地域全体の健康課題を把握する
- 健康問題を早期に発見する
- 必要に応じて医療・介護・福祉へつなぐ

保健は「地域の健康を守る入口」として重要な役割を担う。

保健から医療へ

1 - 地域住民



健康課題→日常生活の中で健康上の不安や問題

2 - 保健活動



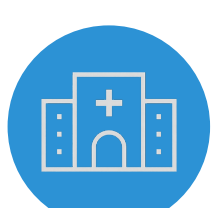
健康相談・健康診断
地域の健康課題の把握 → 住民の健康状態を支援

3 - 受診勧奨



保健師や地域スタッフが適切な
医療機関への受診勧奨 → 早期対応

4 - 医療機関



専門的な診断・治療・
継続的なケアの提供 → 地域医療の拠点として機能

症例を考えます

- **Case**

- **75歳男性**

- 市の健康相談で血圧180/100 mmHgを指摘された
- 喫煙歴40年
- 最近、階段で息切れを自覚している
- 独居だが日常生活は自立している

- **保健として最も適切な対応はどれか。**

- A 経過観察とする
- B 医療機関への受診を勧める
- C 介護保険の利用を勧める
- D 生活保護の申請を勧める

日本の医療制度の特徴

国民皆保険

自由開業制

フリーアクセス

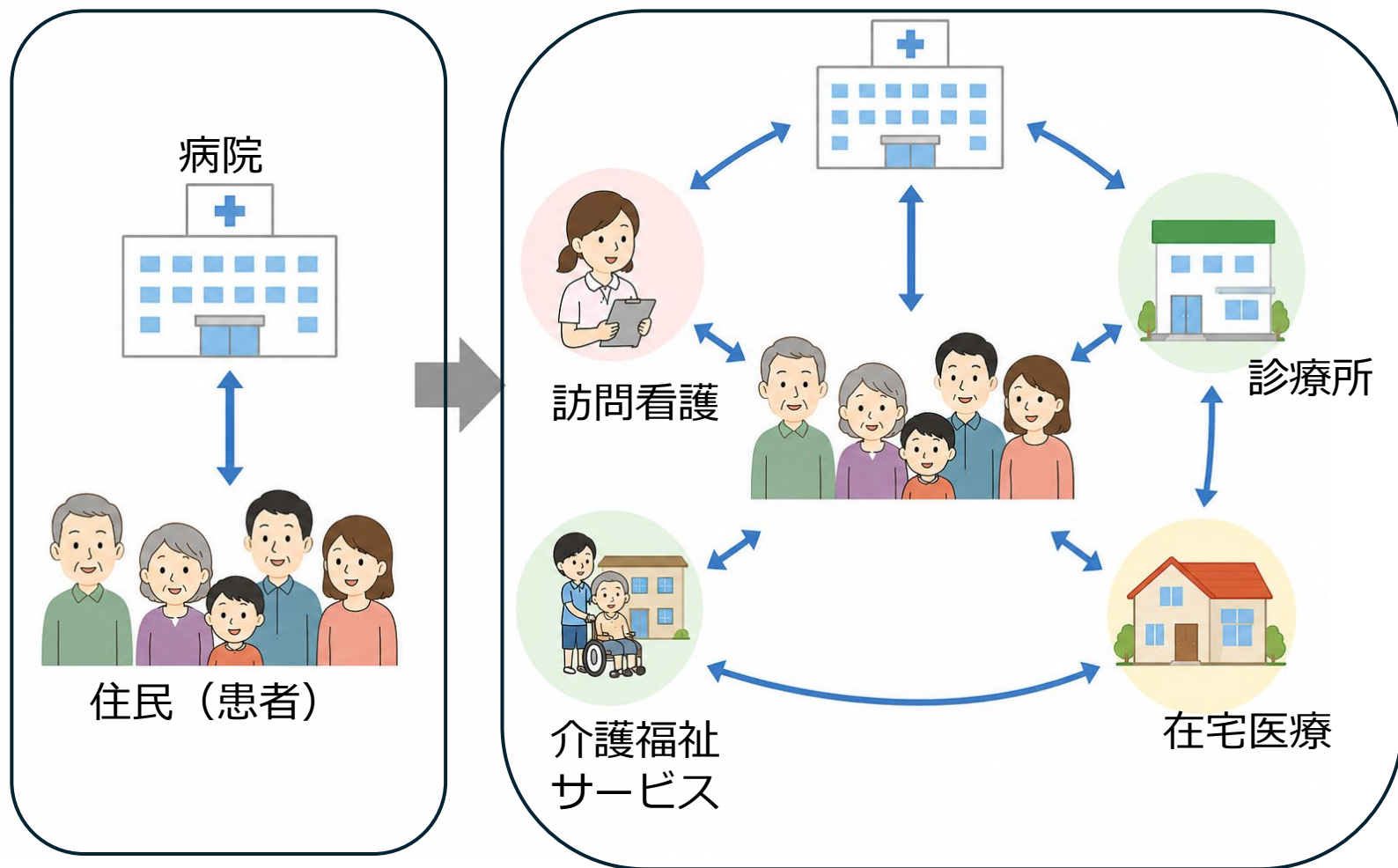
医療制度と地域医療

- ・ 地域医療構想により、急性期・回復期・慢性期を機能分化

- ・ 外来・在宅・施設間の医療連携が課題

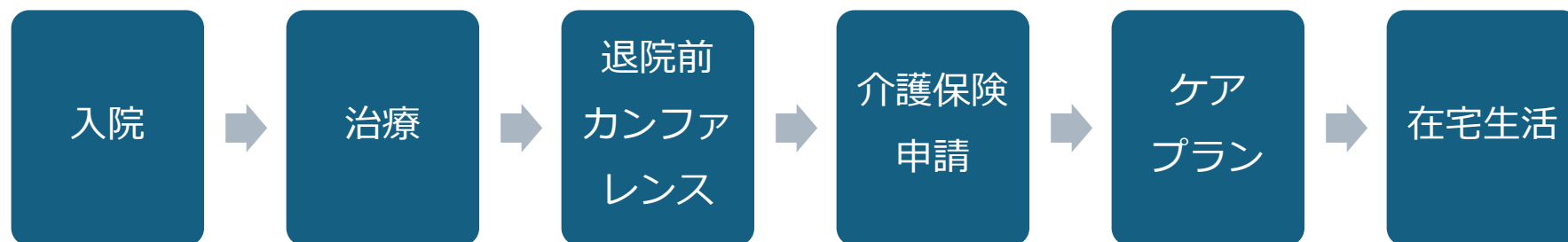
地域医療

病院完結型医療から地域完結型医療へ



高齢化に伴い、医療は病院だけで完結しなくなった。

医療から介護へ



医師の役割

- 治療
- 診療情報提供書
- 主治医意見書
- 退院後の治療方針共有

事例② 退院支援の多職種連携

- Bさん（82歳、脳梗塞後、右麻痺、独居）

①医師ができることは？

②その他にどんな職種との協力が必要ですか？

③制度が利用できる？

介護保険制度

- ・ 2000年施行、40歳以上が保険料負担
- ・ 要介護認定を受けた場合にサービス利用可能
- ・ ケアマネジャーがサービス計画を作成する。

介護保険は「生活機能の支援」の制度。
医療保険とは目的が異なる。

第1号・第2号被保険者

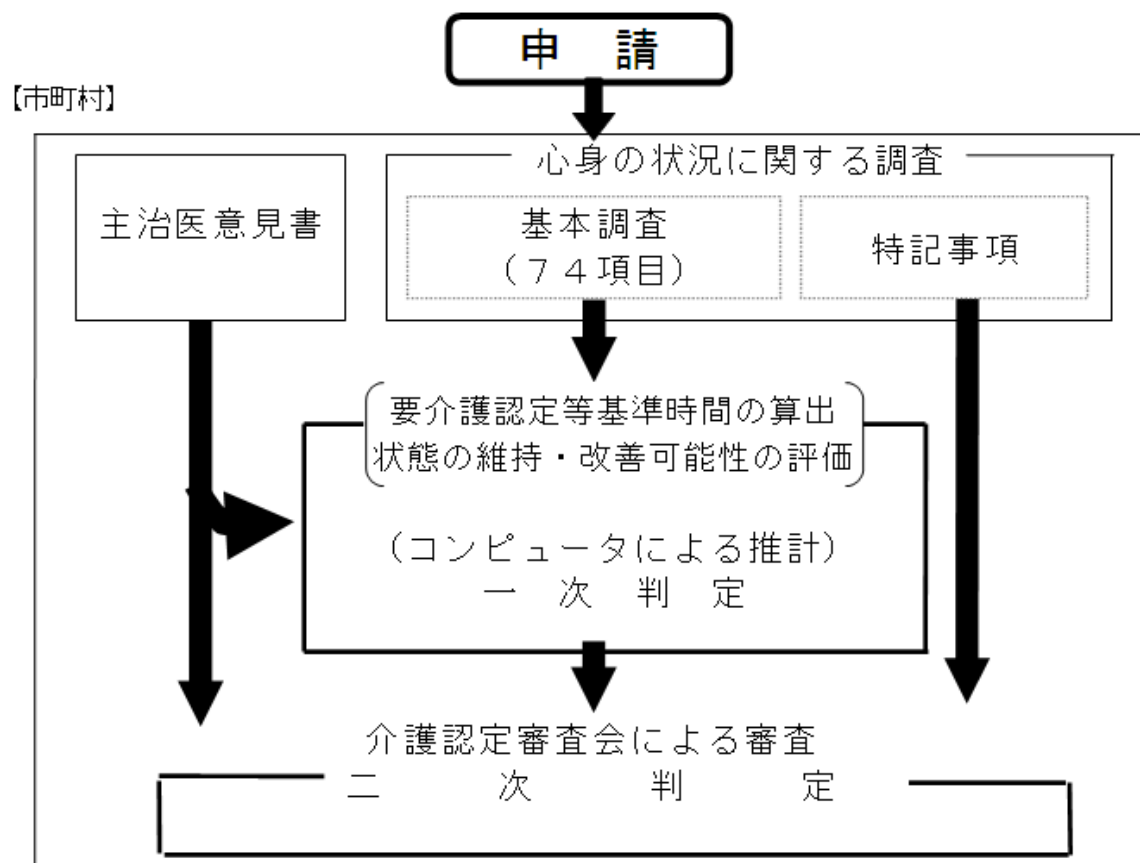
介護保険の対象者

区分	年齢	利用条件
第1号被保険者	65歳以上	原因を問わず要介護・ 要支援状態
第2号被保険者	40～64歳	特定疾病により要介護・ 要支援状態

65歳以上と40～64歳で条件が異なる。

要介護認定

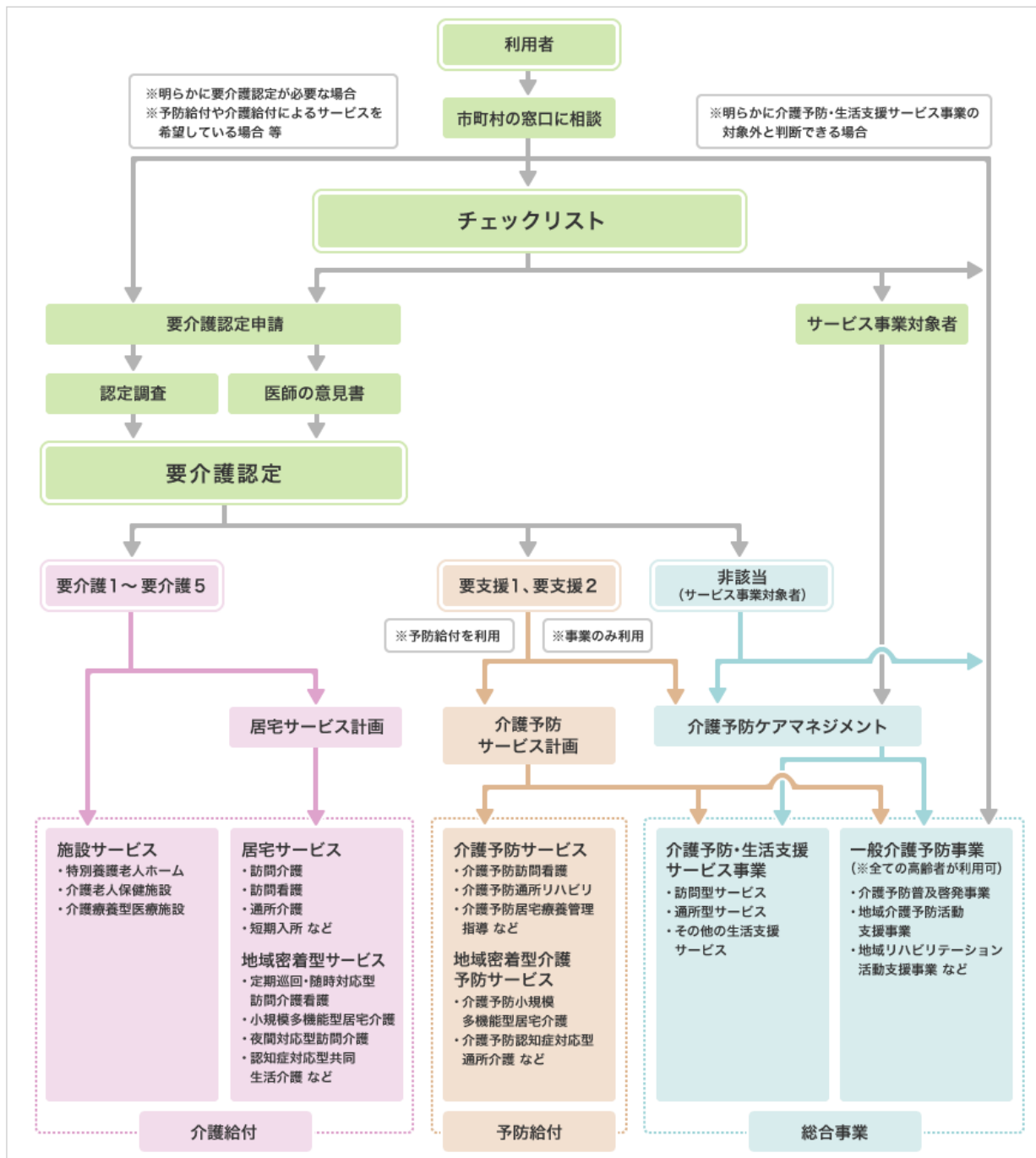
医師は主治医意見書で関与する。
認定結果により利用できるサービス量が変わる。



厚生労働省 要介護認定に係る制度の概要

<https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html>

<総合事業実施後の利用手続>



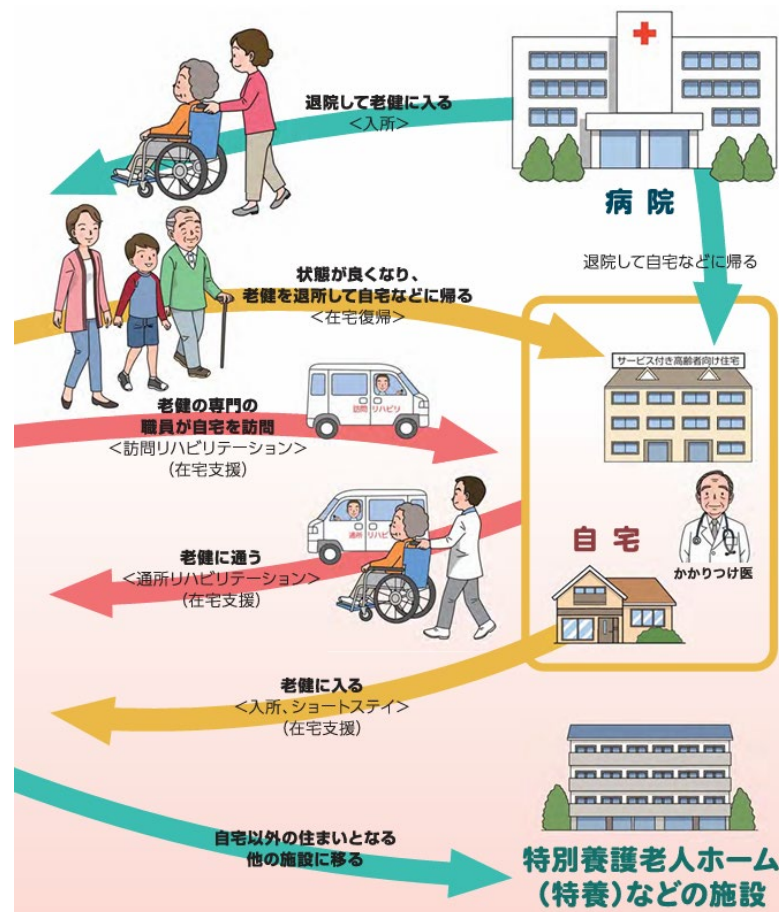
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_syntesis.html

施設サービス

施設	主な役割	対象
特別養護 老人ホーム	生活の場	原則要介護3以上
介護老人保健施設	在宅復帰支援	リハビリが必要な 要介護者
介護医療院	医療的管理＋ 生活の場	医療ニーズの高い 要介護者

介護老人保健施設

老健は在宅復帰を支援する施設である
医療と介護、リハビリを組み合わせる。
病院と自宅の中間的役割を持つ。
在宅復帰を目指す。



事例 認知症高齢者の在宅支援

- Aさん（78歳、認知症軽度～中等度、夫と二人暮らし）

①医師としてできることは？

②知っておきたい情報は

③ほかにどんな職種や制度と連携をとれるか？

事例 認知症高齢者の在宅支援

- ・ 医師：診断と薬物治療、定期的な認知機能評価
- ・ ケアマネ：介護保険認定を経て、訪問介護・通所リハビリを導入
- ・ 看護師：生活習慣管理と服薬指導、家族の不安への対応
- ・ MSW：経済的負担と成年後見制度の活用検討
- ・ 地域包括支援センター：総合相談窓口として全体調整
- ・ 家族と本人の意向を尊重したケアプランの共有と見直しがカギ

福祉の支援体制

福祉とは：生活上の困難を支える制度

- ・ 生活保護：最低限の生活を保障する制度（自治体が実施）
- ・ 障害福祉：就労支援、グループホーム、自立支援給付
- ・ 地域包括支援センターが高齢者支援の拠点として機能

生活困窮者の福祉（生活保護など）

生活保護：最低限度の生活を保障する制度

- 経済的困窮がある場合に検討。
- 医療扶助により医療へのアクセスを支援。
- 申請窓口は福祉事務所。

障がい者福祉

障がい福祉：障害のある人の生活と社会参加を支える

- 居宅介護
 - 就労支援
 - グループホーム
 - 相談支援
-
- 介護保険と障害福祉は対象と目的が異なる。
 - 65歳未満では障害福祉が中心となる場面がある。

児童福祉

児童福祉：子どもと家庭を支える制度

- 児童相談所
 - 市町村の子ども家庭支援
 - 虐待・ネグレクトへの対応
 - 医療機関からの情報提供
-
- 子どもの問題は家庭背景と切り離せない。

医療と福祉の連携

患者の状況	最初に相談する窓口	主な支援内容
医療費が払えない	医療ソーシャル ワーカー（病院）	医療費助成、生活保護、 退院支援
退院後の生活に不安が ある	医療ソーシャル ワーカー（病院）	退院支援、介護保険、 施設調整
介護が必要になった	地域包括支援センター	介護保険、ケアマネ ジャー紹介、介護サー ビス
障害により生活・就労 が困難	障害者相談支援事業所	障害福祉サービス、就 労支援、相談支援

医療だけでは解決できないとき、福祉につなぐ

医療と福祉の連携

患者の状況	最初に相談する窓口	主な支援内容
子どもの虐待・ネグレクトが疑われる	こども家庭センター (市町村) 児童相談所	子どもの安全確保、家庭支援
高齢者虐待が疑われる	地域包括支援センター	高齢者虐待対応、介護・福祉支援
DVが疑われる	配偶者暴力相談支援センター	安全確保、保護、相談支援

医療だけでは解決できないとき、福祉につなぐ

制度の縦割りによる弊害

- ・ 保健、医療、介護、福祉はそれぞれ独立した制度
- ・ 情報共有や責任分担が不明瞭になりやすい
- ・ 退院後に支援が届かない等、患者が制度の狭間に置かれるリスク

地域包括ケアシステムをの構成要素

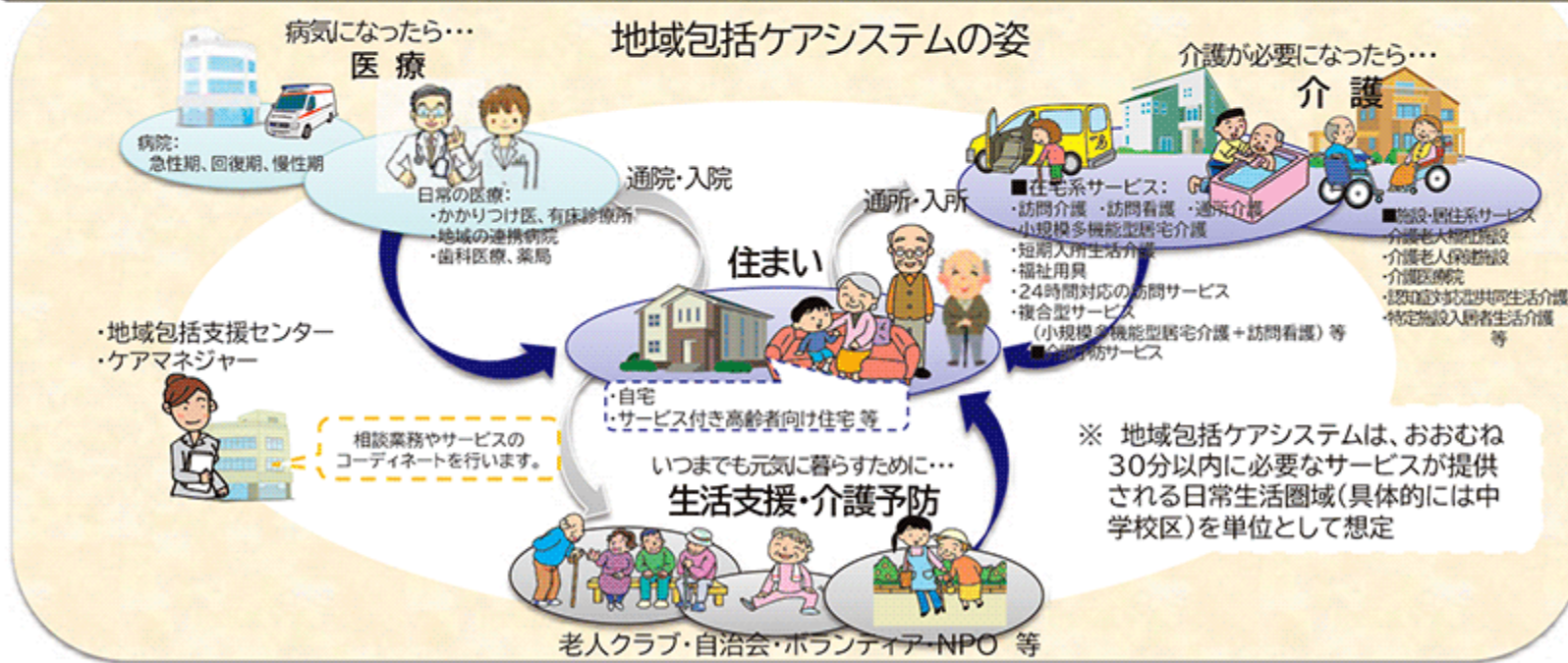


出典：平成28年3月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」

図表2-1-3

地域包括ケアシステムの構築について

- 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、**医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。**
- 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。
- 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、**高齢化の進展状況には大きな地域差。**
- 地域包括ケアシステムは、**保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。**



地域包括ケアシステムの構成

- ・ 高齢者が地域で自立した生活を送るための仕組み
- ・ 医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
- ・ 地域包括支援センターが中核的な役割を果たす

地域包括支援センター(地域包括ケアシステム)のイメージ

被保険者

総合相談・支援事業

虐待防止・早期発見、権利擁護

多面的(制度横断的)支援の展開

行政機関、保健所、医療機関、児童相談所など必要なサービスにつなぐ

虐待防止

介護サービス

ボランティア

医療サービス

ヘルスサービス

成年後見制度

介護相談員

地域権利擁護

民生委員

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

- ・日常的個別指導・相談
- ・支援困難事例等への指導・助言
- ・地域でのケアマネジャーのネットワークの構築

多職種協働・連携の実現支援

ケアチーム

連携

主治医

ケアマネジャー

社会福祉士等

主任ケアマネジャー等

チームアプローチ

保健師等

介護予防ケアマネジメント事業

- ・アセスメントの実施
- ・プランの策定
- ・事業者による事業実施
- ・再アセスメント

居宅介護支援事業所

主治医

新予防給付・介護予防事業

- ・センターの運営支援、評価
- ・地域資源のネットワーク化

- ・中立性の確保
- ・人材確保支援

介護保険サービスの関係者

利用者、被保険者(老人クラブ等)

地域医師会、福祉関係団体、介護支援専門員等の職能団体

地域包括支援センター運営協議会

NPO等の地域サービスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

⇒市区町村ごとに設置
(市区町村が事務局)

包括的支援事業の円滑な実施、センターの中立性・公正性の確保の観点から、地域の実情を踏まえ、選定。

多職種連携の定義と必要性

多職種連携（interprofessional collaboration）とは：

- ・ 複数の専門職が共通の目標（例：患者のQOL向上）のもとに協働
 - ・ 医師主導型から、チーム主導型・患者中心型へと変化
-

なぜ今、多職種連携が求められるのか：

- ・ 高齢者の増加、慢性疾患の増加、多様な生活背景への対応
 - ・ 医療のアウトカムだけでなく、生活全体を支える視点が不可欠
 - ・ 限られた医療資源のなかで、効率的かつ効果的な支援が必要
-

地域医療を構成する人的要素

- 医師
- 歯科医師
- 介護支援専門員（ケアマネージャー）
- 看護師
- 保健師
- 薬剤師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士（ソーシャルワーカー）
- 介護福祉士
- 精神保健福祉士
- 管理栄養士
- 歯科衛生士
- 言語聴覚士
- 訪問介護員（ホームヘルパー）
- 民生委員

連携する職種の役割と視点の違い

職種	主な視点
医師	診断・治療
看護師	療養生活
薬剤師	薬物治療
PT/OT/ST	機能・生活動作
MSW	生活・制度
ケアマネジャー	介護サービス調整

- 職種により見ているものが違う。
- 違いがあるから連携が必要である。

多職種連携の課題

情報共有が不十分：

- 電子カルテが職種間で分断されている（例：医療-介護-福祉）
- 紙ベース・FAXなど非効率な方法が残る

職種間の認識のずれ：

- それぞれが「自分の役割」を重視しすぎると連携が滞る

忙しさと時間不足：

- カンファレンス開催が形骸化
- 事前情報の読み込み不足で的確な意見交換ができない

解決の鍵：共通言語・信頼関係・顔の見える関係構築

効果的な連携のための方策

共有ツールの活用：

- 地域連携パス、退院サマリー、介護連携シートの標準化

定期的なカンファレンス・ケース検討会の開催

多職種合同研修の実施：職種間の相互理解の促進

医師に求められる姿勢：

- 自らの専門性と限界を理解する
- 他職種の意見を尊重し、支援を依頼できる力
- チームのリーダーとしての柔軟な調整力（必ずしもリーダーになる必要もない）

事例③

- 外来にきた低体重の1歳児 (-2.7SD)
- 診察上は活気はあり

①医学的に何を考える？

②養育環境として何に注目する？

③どの機関と連携するか？？

医学生に求められる視点

実習での姿勢：

-
- ・ 医療現場だけでなく、福祉施設、保健所など多様な場面に関心を持つ
 - ・ 「この患者さんに必要な支援は医療以外に何かあるか？」を考える
-

他職種との関わり：

-
- ・ カンファレンスや面談に積極的に参加
 - ・ 連携の実際を観察・記録し、将来の実践に生かす
-

目指すべき医師像：

-
- ・ 医療の専門家＋地域のつなぎ手（コーディネーター）
-

まとめ

保健・医療・介護・福祉は異なる制度だが、支援対象者にとっては一体

SDHの視点に立てば、医療以外の支援が健康に直結する

多職種連携は、信頼とコミュニケーションに基づく協働

医師は、専門家であると同時に、他職種との橋渡し役でもある